

楼里：室内导航商业调研与客户访谈手册

研究日期：2026-10-07（北京时间）。用途：IDP 创业管理班汇报、团队商业决策、医院与商场初次合作洽谈。公开资料免费检索；未开展客户访谈、真实场地测试或付费数据库采购。

建议先卖一个可验收的小范围试点

楼里已有医院与商场网页仿真，能够解释路线、多点任务和模拟队列；尚无真机定位性能、生产系统接入、授权客户地图或成交证据。当前最适合提出的是“共同确认一个找路或流程问题，完成范围明确的路线服务试点”。医院主线可以讲清就诊任务，商场主线可以讲清目的地查找；两类客户应分别判断价值与预算，不能共用一套收入承诺。

公开采购证明医院导航曾进入实际预算和合同，不能证明本地目标医院当前有预算。地图平台和专业厂商已经提供室内地图、定位与路线能力，所以“能显示地图和规划路径”本身难以成为差异化。楼里的潜在差异应在业务流程配置、地标式指引、错误信息反馈以及小范围交付效率上验证。该判断为基于公开来源的商业推论，尚未得到客户验证。

1. 免费研究得到的商业证据

来源及时间	可核验事实	对楼里的意义	不能推导什么
洛阳市东方人民医院院区智能导航系统竞争性磋商公告，2025-06-06	预算及最高限价 20 万元；院方提出改善患者路线服务	患者体验可能形成独立导航采购项目	预算并非成交；不能视为我们的单层试点售价
常州市第一人民医院室内导航管理系统合同公告，2025-05-13	合同金额 69 万元；公开招标；履约期限标注 2 年	导航系统存在实际合同；服务周期与交付责任重要	公告摘要没有完整工作量，不能比较单价或估算利润
徐州市中心医院院内导航公开招标公告，2025-11-18	预算 150 万元；两个院区约 20 万平方米；要求合同后 45 天完成部署调试	大项目包括现场实施、跨院区范围与进度承诺	不是小试点；不是楼里能立即履约的能力证明
空军第九八六医院院内导航采购意向，2026-09-29	预算 93 万元；意向含地图系统、至少 800 个蓝牙信标及 2 台服务器	硬件、服务器、地图与实施可能捆绑采购	仅意向，非最终招标/合同；不代表通用设备密度
杭州市第一人民医院 2025 年 7 月信息化项目第二次市场调研，2025-07	文件列出智能导航，要求室内定位、科室路线规划和就诊节点提醒；需公司资质、服务材料及售后等	本地历史材料可用于准备买方问题；创业团队宜考虑集成商渠道	智能导航位于综合软件范围中，不能拿综合预算当导航单项预算；报名已结束

这些项目在地区、面积、硬件、接口、维保与采购阶段上差异很大。本研究不以其最低与最高金额制造“市场价格区间”，也不把项目数量外推成市场规模。检索时剔除了手术导航、穿刺定位等临床设备项目，它们与患者寻路不是同一市场。

2. 现有解决方案与替代方案

方案	官方可见能力或形态	对楼里的取舍
高德室内地图产品、JS API 室内图层文档	地图展示、室内 POI、路线规划；文档提供楼层与建筑选择等接口；未覆盖地图可找认证生产合作商	可以研究其作为底图/能力提供方，但须另核目标建筑覆盖、商用许可、数据生产与端支持；图层展示不等于我们已经接入实时定位
百度室内地图	楼层切换、2D/3D、POI、路线指引、普通与 AR 步行导航；页面提示未支持定位的场地可联系采集	平台方案是重要替代；页面部分覆盖数字明确为截至 2020 年 6 月，故本研究不当作 2026 市场规模

方案	官方可见能力或形态	对楼里的取舍
蜂鸟视图导航导览产品	多种路线偏好、模拟与实时导航、业务图层；H5、小程序、大屏模板与地图维护能力	地图与导航功能有成熟竞争者。官网“5000元即可拥有”属于营销入口，具体地图、硬件、并发与服务边界未核验，不作为完整项目报价
场馆已有导视牌、客服、服务台、官方 APP/小程序	现场可用，无需用户另装工具；实际质量需访谈	客户可能更愿意改标识或优化现有系统，必须确认数字导航增加了什么价值

上述厂商能力均是官方产品说明，不是第三方性能测试，也不证明在目标医院/商场有效。楼里不应宣称“业内首创”“定位更精准”或已经优于这些系统。初期可借用合规供应链与地图服务，将资源投入业务理解与交付；合作条件仍待询价。

3. 医院与商场分开销售

内容	医院	商场
使用者	首次就诊者、陪诊家属、行动不便者	顾客、停车用户、访客
业务推动人（待访谈确认）	门诊办、患者服务/导诊负责人	客服运营、商业运营、会员数字化负责人
技术/采购与签约者	信息科、采购部门、院方签约主体；也可能为集成商	IT/物业/集团数字化；预算与签约可在场馆或集团
优先痛点假设	科室别名、跨楼层、下一项任务、反复问路	找店与设施、跨楼层、无障碍、返回停车位置
首个产品包	一层楼、两至四个节点的流程路线；人工规则与扫码起点	一层楼、指定门店及公共设施查询；扫码起点与路线反馈
有条件的增强包	经院方授权接入队列/预约，流程提示；手机与信标验证	经场馆授权接入店铺目录/停车信息/活动；手机与信标验证
验证指标	无额外问路到达比例、找路时间、每百人问路次数、路径错误	指定目的地到达比例、找店时间、客服问路、目录维护耗时
收入	地图配置与部署项目费+年度维护；接口与定位单列	部署与目录服务+年度维护；停车/会员对接单列

医院流程顺序与检查准备规则由院方确认；导航不替患者做医疗决策。商场导航到店不等于成交，消费增长只能在合规取得数据并设计对照后评估。初期不建议靠出售位置轨迹、患者数据或“广告一定转化”作为收入故事。

4. 首轮合作方案：把承诺写成可验收范围

建议周期为 4—6 周，这是资源具备后的计划假设，并非已承诺工期。先确认一层楼或一条短流程、20—30 个目的地、固定扫码起点，使用授权地图与匿名测试编号；暂不读取真实病历或接入生产系统。定位硬件、实时队列、会员与停车接口另签范围并单独验证。

- 场馆提供：地图使用授权、可通行与无障碍信息、正确的目的地/流程规则、现场观察许可、一位业务负责人及维护负责人。
- 楼里拟交付：试点地图与目录、二维码起点及路线页面、异常与错误反馈、配置台账、培训与验收报告。管理功能仍需开发，应在方案内注明待交付。
- 拟测量：同一路线、相近时段安排两组测试，记录年龄/熟悉度等影响因素；首轮建议累计 30—50 次路线任务，属于可行性观察，不能直接外推院区平均效果。
- 拟议继续条件：重大路线错误为零；目标到达与找路时间相对基线有改善；负责人愿意维护；客户确认采购/扩展路径。具体阈值在试点前共同签字，当前未取得客户认可。
- 停止或缩减：地图无授权、无人维护、入口无法曝光、业务方认为现有方案够用、关键接口不可获得或现场定位无法可靠回退。

入口曝光应记录：看到二维码的人数、打开人数、开始路线人数、完成任务人数。只有用户愿意打开并找到目的地，地图功能才可能创造商业价值。匿名统计口径、保存期与访问权限应由双方确认。

5. 报价结构与单位经济：全部是内部情景假设

以下不是报价单、厂商询价结果或成交记录。正式报价需勘察后按楼层/面积、目的地数量、地图生产、终端、接口、设备、部署方式、服务周期与验收条件确认；含税情况及第三方许可另列，防止重复收费。

拟议范围	讨论用金额	说明
业务访谈+勘察+试点设计	0.3—0.8 万元	小型有偿诊断的定价假设；是否抵扣部署费协商
医院一层短流程试点	2—5 万元	授权地图、20—30 个 POI、扫码起点；无生产接口/实时定位
商场一层目的地服务试点	1.5—4 万元	目录与路线；已有地图且不含停车/会员接口
年度维护	0.6—1.8 万元/场馆	更新次数、响应时间、托管与许可边界写入合同
定位/接口增强及全馆扩展	另行估算	先现场验证、接口确认、供应商询价，再报价；不写空泛“全包价”

为了算清一单是否值得做，选一个**医院扫码路线试点**：假设收入 30,000 元，12 人日 ×800 元 =9,600 元；地图整理 2,000 元、托管 600 元、现场差旅 1,800 元、测试培训 2,000 元、风险预留 2,000 元，交付成本共 18,000 元；另假设获客与商务投入 4,000 元。每单增量贡献 =30,000-18,000-4,000=8,000 元，占收入 26.7%。这是税前增量贡献，未扣研发、固定薪酬/场租、折旧与融资成本，不能叫净利润。

情景（仅变化所列项）	收入	交付成本	获客成本	增量贡献
基准	30,000	18,000	4,000	8,000
客户降价 20%	24,000	18,000	4,000	2,000
人日由 12 增至 18	30,000	22,800	4,000	3,200
加 15% 渠道费	30,000	18,000	8,500	3,500
工期与渠道同时增加	30,000	22,800	8,500	-1,300

渠道情景把 4,500 元渠道费加入原商务成本，是否实际重复应按合同核实。若年度维护收入 12,000 元、更新支持/托管/第三方费用共 6,000 元，则年度增量贡献为 6,000 元，续费率未知，不能据此预测 LTV。若团队每月固定支出假设 24,000 元、每单贡献 8,000 元，仅覆盖固定支出需约 3 单/月；早期项目销售能否达到尚无证据，不能转写成销量计划。

医院与商场历史采购金额只用于证明采购存在。楼里的这些金额来自工作量假设，与历史大项目不具可比性。签约前还应把预付款、验收付款、客户变更、地图移交及后续维护责任谈清，按资金到位情况控制垫资。

6. 获客与官方合作渠道

医院路线：先请门诊服务负责人做 30 分钟业务访谈，再请信息科判断现有供应商、接口与采购要求；同步寻找有院内交付经验的医疗信息化集成商。杭州市第一人民医院历史调研文件显示需要企业材料、产品/参数与售后等，适合用来准备资料包；**2025 报名已结束，不能按旧邮件当作正在招标**。后续须查看医院官网当前公告并核对联系人。团队若尚无公司主体和交付业绩，宜通过合格合作主体参与，而非直接承诺独立投标。

商场路线：先通过现场服务台/官方账号请求运营或数字化负责人的转介，展示“一次找店任务”，询问集团是否已有导航和统一采购。门店品牌可反馈痛点，但通常不能授权全馆地图或批准公共区域布设。

可核验的公开转介入口如下；它们不是采购负责人，也不意味着合作已建立：

- 银泰集团**官方综合事项渠道**：综合事项电话为 +86-10-8540-5700。媒体邮箱专用于采访拍摄，不能当作产品采购邮箱；建议只请求转介相关场馆运营。

- **龙湖官方客户服务**：天街服务 950966，可用于询问对应场馆的公开运营联系入口；客服不是采购审批人。
- **蜂鸟视图官网**提供官方商务联系及渠道入口，可作为地图/SDK/定位供应链询价候选；尚未接洽。
- **高德官方室内产品页面**提供商务合作与地图生产合作商入口；合作资格、版权许可、费用与导出条件需确认。

西溪银泰城仅是未来真实地图导入候选。银泰旧版官方新闻目录中有该项目历史条目，但本次访问其详情出现不匹配的重定向；未核到当前楼层图授权、地图文件、技术负责人或合作意向。因此不要在演示/销售材料中写“已覆盖西溪银泰”“与银泰合作”或伪装成官方地图。先访谈确认经营主体及授权渠道，再决定是否使用真实品牌与平面图。

7. 客户访谈清单：每个问题都对应一个商业决定

1. 上周最常见的五类问路是什么？有无客服/导诊记录、时段和地点？——判断真实痛点，避免凭团队想象。
2. 用户现在用导视牌、官方小程序还是问人？哪个环节最差？——判断需要替代、增强或停止。
3. 谁承担服务指标，谁维护地图，谁批准预算，谁签合同？——确认推动人、经济买方与交付责任。
4. 是否已有地图、导航、定位或会员/叫号供应商？合同允许增加模块吗？——判断渠道与集成路径。
5. 可否提供一层楼授权图及通行规则？需要谁审批设备/二维码/观察活动？——确认试点可执行性。
6. 科室/店铺变化如何通知，临时封路谁更新，多久更新？——估计维护工作量与续费内容。
7. 愿意把哪个流程/目的地作为试点？愿意用什么指标、样本和基线验收？——形成可复核价值证明。
8. 哪些数据可读取，接口由谁提供，是否收费、测试环境可用吗？——不让未知接入成本侵蚀贡献。
9. 能在官方入口放二维码或按钮吗？每周大约能触达多少人，如何计数？——验证使用率。
10. 这项需求归哪项预算？什么采购方式和审批节奏？试点通过后的下一步是什么？——验证付费路径。
11. 可接受怎样的服务周期、故障回退、地图移交和退出方式？——估计长期交付成本。
12. 若现有系统能用，为什么愿意换/增加楼里？若暂不付费，主要原因是什么？——形成真正的竞争判断。

每次约访输出一页记录：受访者角色、原话与证据、需求严重度、当前替代方案、预算状态、授权条件、下一步负责人；未经许可不公开姓名/录音。建议先做 6—10 次跨角色访谈，这是工作计划而非已完成的客户数量。

8. 关键缺口与白皮书采购判断

目前暂无需采购白皮书。免费官方采购与产品资料已经足以支持第一轮沟通；最大的未知是本地客户需求、授权、预算、接入与付费意愿。通用行业报告无法替代这些答案，也无法证明楼里的真机效果。

如访谈后仍有影响商业决策的明确空白，最多考虑两个采购主题（尚未确认具体出版物，不编书名）：

- **中国医院患者服务/室内导航采购与更新预算研究**：用于判断目标地区采购周期、签约结构与渠道进入成本。购买前核实作者/机构、年份、样本数、地区/医院等级、问卷及原始来源；索取样章确认导航与手术定位没有混算，预算与成交没有混算。若只有总市场规模图，不买。
- **购物中心数字服务采购与运维研究**：用于判断运营/集团数字化部门的预算、续费动机与现有供应商关系。要求有可追溯场馆样本、功能与费用边界、会员/停车/导航分项以及实际采购角色；无数据口径、无方法或只汇编厂商营销，不买。

每份付费资料需对应一个会改变选择的问题、一个具体使用章节和可检查的数据口径；先取得样章并与免费资料比对。采购决定应在这些条件具备后再做，当前没有发起购买。

9. 下一轮优先级与证据状态

优先取得一个业务负责人、一个授权场地、一个可比基线和一个采购路径。建议先用现有仿真谈需求，再实施扫码路线试点；定位硬件与真实队列接入按现场证据推进。商场保留为平行访谈与展示场景，不同时承诺两个行业的大规模定制。

判断	当前状态	需要补充的证据
医院导航存在采购需求	官方历史采购/合同支持	目标院方当前预算与决策人
商场有愿意付费的导航痛点	仅产品/渠道与场景假设	运营访谈、现有方案不足、试点预算
楼里能改善找路/流程体验	网页仿真能说明故事	授权现场任务对照与用户反馈
真机定位可靠	未验证	手机/场地/密度条件与失败回退测试
小项目能盈利	内部工作量情景	实际工时、许可费、获客与售后成本
可以规模复制	未验证	第二个独立场馆的实施与维护成本

公开页面可能改版，部分旧链接有重定向；检索日期不代表原内容刚更新。医院采购案是有目的选择的案例集合，不是完整市场抽样。本报告不提供市场总规模、融资估值、已签客户名单或销售增长预测。来源范围和缺口应与 BP 一起保留。